췌담관 합류이상·담관낭종

APBDU와 담관낭종이 동반된 경우의 전문 의뢰

췌담관 합류이상(APBDU)과 담관낭종(choledochal cyst)이 함께 있는 경우를 강의에서 별도 수술 고려 상황으로 제시했다.

핵심 판단의 흐름



강의에서 설명한 위험의 연결

요소	원자료의 설명
동반 이상	담관낭종과 APBDU가 함께 동반되는 상황을 설명했다.
역류 기전	담관보다 췌장 쪽 췌액 압력이 높아 췌액이 담도 쪽으로 역류한다.
암 위험	이 역류가 담낭암을 더 많이 만드는 것과 관련된 근거가 있다고 설명했다.

전문 진료로 연결할 때

확인 내용	강의의 적용
진단의 조합	담관낭종과 췌담관 합류이상의 동반 여부를 구분해 전달한다.
수술 상담	연자는 APBDU가 있는 경우에도 담낭절제술을 권유한다고 설명했다.
무증상 담석 문맥	강의 결론은 악성종양이 의심되거나 위험이 있는 경우를 무증상 담석의 수술 고려 대상에 포함했다.

진료실에서 기억할 점

단순 무증상 담석과 췌담관 구조 이상을 구분한다. APBDU·담관낭종이 의심되면 구조 이상과 암 위험을 평가할 전문 진료로 연결한다.